

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE PCR E ACLS NA
ENFERMARIA

Reconhecimento • RCP de Alta Qualidade • DEA/Desfibrilação • Ritmos • Drogas • Pós-PCR

■ LIGUE AGORA para o Código Azul/PCR da instituição. Chame ajuda. Inicie RCP imediatamente. NÃO abandone o paciente.**■ Baseado em: AHA ACLS Guidelines 2020/2023 Update • ILCOR CoSTR 2023 • SBC Diretriz de RCP 2022**

1. RECONHECIMENTO DA PCR — SEQUÊNCIA IMEDIATA

Segundo	Ação	Detalhe
0–10s	Verificar segurança + avaliar vítima	Chamar pelo nome. Estimular ombros. Sem resposta = emergência
10s	Chamar AJUDA + acionar Código Azul	Gritar por socorro. Ligar para código azul. Pedir DEA/carrinho de PCR
10–30s	Verificar pulso + respiração SIMULTANEAMENTE	Pulso carotídeo ≤ 10 segundos. Respiração normal? (gaspings NÃO conta)
< 30s	SE SEM PULSO OU DÚVIDA → INICIAR RCP	NÃO perder tempo. Em caso de dúvida: INICIAR RCP. É mais seguro.
Imediato	Posicionar para RCP	Paciente em decúbito dorsal em superfície RÍGIDA. Baixar grades da cama.

2. RCP DE ALTA QUALIDADE — PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS

Parâmetro	Meta / Detalhe
Frequência das compressões	100–120 por minuto. Contar em voz alta: 1-2-3...30
Profundidade das compressões	5–6 cm (adulto). Deprimir o esterno. NÃO menos de 5 cm.
Retorno total do tórax	Não apoiar o peso no tórax entre compressões. Recuo completo.
Interrupções	Minimizar ao máximo. Pausa máxima de 10 segundos (carga/choque/via aérea)
Relação compressão:ventilação	30:2 sem via aérea avançada. Contínuas (100-120/min) + 10 vent/min com via aérea avançada
Ventilação (bolsa-máscara)	Volume suficiente para elevar o tórax. 1 segundo por ventilação. Evitar hiperventilação
Via aérea avançada	IOT ou máscara laríngea. NÃO interromper RCP > 10s para intubar
Rodízio do compressor	Trocar a cada 2 minutos (ciclo de 5x30:2) para evitar fadiga. QUALIDADE > CONTINUIDADE

Parâmetro	Meta / Detalhe
Capnografia (se disponível)	PETCO2 < 10 mmHg após 20 min = indicador de RCP inadequada ou prognóstico ruim

■ TEMPO DE PRIMEIRO CHOQUE: < 2 minutos do reconhecimento para o 1º choque em FV/TVSP. Meta institucional: < 3 minutos.

3. ALGORITMO POR RITMO — DESFIBRILÁVEL vs NÃO DESFIBRILÁVEL

RITMOS DESFIBRILÁVEIS — FV / TV Sem Pulso

Ciclo	Ação
Ciclo 1	RCP 2 min → Verificar ritmo → FV/TVSP → 1º CHOQUE (bifásico 200J ou máx monofásico 360J) → RCP imediata 2 min
Ciclo 2	Verificar ritmo → FV/TVSP → 2º CHOQUE → RCP 2 min → Adrenalina 1 mg EV (repetir 3/3 min em todos ciclos ímpares)
Ciclo 3	Verificar ritmo → FV/TVSP → 3º CHOQUE → RCP 2 min → Amiodarona 300 mg EV (dose única; 2ª dose 150 mg no ciclo 5)
Ciclos 4+	Repetir sequência: RCP → Verificar → Choque → Adrenalina 3/3 min → Amiodarona 2ª dose no ciclo 5

RITMOS NÃO DESFIBRILÁVEIS — AESP / Assistolia

Ciclo	Ação
Ciclo 1	RCP 2 min contínua → Adrenalina 1 mg EV imediatamente → Verificar ritmo a cada 2 min
Ciclos 2+	RCP 2 min → Adrenalina 1 mg EV a cada 3–5 min → Investigar e tratar causa reversível (Hs e Ts)
Assistolia	NÃO desfibrilar. Excluir "line noise". Confirmar em 2 derivações. Tratar causas reversíveis.
AESP	Atividade elétrica sem pulso: investigar Hs e Ts. USG beira do leito se disponível

4. CAUSAS REVERSÍVEIS DA PCR — Hs e Ts

H/T	Causa	Diagnóstico Beira do Leito	Tratamento
H1	Hipovolemia	Contexto (hemorragia, sepse, diarreia). USG VCI	Cristaloide 1–2L rápido. Transfusão se hemorrágico
H2	Hipoxia	Posição da cânula, expansão, SpO ₂	Ventilar, reposicionar IOT, ventilar com O ₂ 100%
H3	H ⁺ (Acidose)	Gasometria, contexto de acidose grave	Bicarbonato 1 mEq/kg EV se pH < 7,1
H4	Hipo/Hipercalcemia	ECG (onda T apiculada, QRS alargado). K ⁺ sérico	Gluconato Ca 10% EV. Bicarbonato. Insulina/Glicose
H5	Hipotermia	Temperatura central. Contexto	Reaquecimento ativo. RCP prolongada
T1	Tensão pneumotórax	Desvio de traqueia, ausência de MV unilateral	Toracocentese de alívio imediata (2º EIC LMC)
T2	Tamponamento cardíaco	USG beira do leito (derrame + colapso de VD)	Pericardiocentese de emergência
T3	Trombose (coronária / TEP)	Contexto. ECG (ST). USG (cor pulmonale agudo)	IAM: cath urgente. TEP: trombolítico durante RCP
T4	Tóxicos / Overdose	Contexto. QRS alargado, QT longo	Bicarbonato (ADT). Naloxona (opioides). Específico

5. DROGAS NA PCR — DOSES E INDICAÇÕES

Droga	Dose	Via	Indicação / Observação
Adrenalina (Epinefrina)	1 mg EV Repetir 3–5 min	EV ou IO (preferir central)	TODOS os ritmos. Vasopressor + efeito cronotrópico. NÃO interromper RCP para dar
Amiodarona	300 mg EV (1ª) 150 mg EV (2ª)	EV ou IO em bolus diluído em 20mL SG	FV/TVSP refratária (após 3º choque). Diluir em SG 5% se via periférica
Lidocaína (alternativa)	1–1,5 mg/kg EV 0,5–0,75 mg/kg (2ª)	EV ou IO	Alternativa à amiodarona na FV/TVSP. Máx 3 mg/kg total
Bicarbonato de sódio 8,4%	1 mEq/kg EV (50 mL = 50 mEq)	EV em bolus	Hipercalemia grave, acidose severa (pH<7,1), intox. ADT. NÃO rotineiro
Sulfato de Magnésio	1–2 g EV em 5 min	EV em bolus	Torsades de pointes, FV refratária associada a hipomagnesemia
Atropina	NÃO usar na PCR	—	Sem benefício em assistolia/AESP. Pode ser usada em bradicardia com pulso
Gluconato de Cálcio 10%	10 mL EV (1 ampola)	EV lento	Hipercalemia grave, hipocalcemia, intox. por BCC
Naloxona	0,4–2 mg EV/IM	EV, IM ou intranasal	Overdose de opioide. Efeito dura 30–90 min; repetir se necessário

6. CUIDADOS PÓS-PCR — SÍNDROME PÓS-PARADA CARDÍACA

Domínio	Meta	Conduta
Oxigenação	SpO ₂ 94–98% PaO ₂ 60–100 mmHg	Evitar hiperoxia (FiO ₂ mínima para atingir meta). Gasometria de controle
Ventilação	PaCO ₂ 35–45 mmHg (normocapnia)	Evitar hiperventilação. PETCO ₂ alvo 35–40. FR 10-12/min em VM
Hemodinâmica	PAM ≥ 65–70 mmHg PAS ≥ 90 mmHg	Noradrenalina se necessário. Dobutamina se baixo débito. Ecocardiograma precoce
Temperatura-alvo	Controle térmico 32–37,5°C por 24–48h	EVITAR febre (> 37,5°C) nas primeiras 72h. Tratamento ativo se indicado
Glicemia	140–180 mg/dL	Insulinoterapia. EVITAR hipoglicemia (< 70). Dosar 1/1h inicialmente
Neurológico	Prognóstico ≥ 72h	TC crânio precoce. EEG se crise suspeita. Não progredir prognóstico < 72h
Cardiológico	Identificar causa	ECG 12D imediato. Cateterismo se suspeita de SCA. Enzimas cardíacas seriadas
UTI	Admissão imediata	TODO sobrevivente de PCR → UTI. Monitoração contínua 24–48h mínimo

7. REGISTRO DA PCR — FICHA DE REGISTRO

■ Registrar **TODOS** os dados em tempo real durante a PCR. Delegar anotador no início do atendimento. Documentar no prontuário imediatamente após.

Hora da PCR reconhecida:	____:____	Ritmo inicial:	_____
Hora 1ª compressão:	____:____	Causa suspeita:	_____
Hora 1º choque:	____:____	Hora 1ª adrenalina:	____:____
Hora IOT:	____:____	Hora amiodarona:	____:____
Hora RCE (retorno circulação):	____:____	Tempo total de RCP:	_____ min
Hora suspensão:	____:____	Desfecho:	RCE / Óbito
Compressor 1:	_____ _____	Compressor 2:	_____ _____
Médico responsável:	_____ _____	CRM:	_____

Referências: AHA ACLS Guidelines 2020; Panchal AR et al. Circulation 2020; ILCOR CoSTR 2023; SBC – Diretriz de RCP e Emergências Cardiovasculares 2022.